

УДК:616.345-006.7-07

М.А. Кузикеев, С.В. Лашкул, А.И. Джуманов, Т.С. Насрытдинов,
Р.К. Мустафина, О.А. Александрова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Результаты радикального хирургического лечения колоректального рака у лиц старческого возраста

Аннотация. В данной работе освещаются непосредственные результаты хирургического лечения колоректального рака (КРР) у 50 больных в возрасте с 75 до 92 лет за период с января 2011 года по октябрь 2016 года. Произведена оценка: объема кровопотери, длительности операций, послеоперационных осложнений, продолжительности пребывания пациента в стационаре, длительности послеоперационного периода. Уделялось особое внимание предоперационной подготовке, так как у людей старческого возраста имеются тяжелые сопутствующие патологии, требующие коррекции.

Ключевые слова: колоректальный рак, старческий возраст, резекция толстого кишечника.

Актуальность. В мире ежегодная заболеваемость колоректальным раком достигает 1 миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 500.000. Колоректальный рак занимает второе место по смертности от злокачественных новообразований среди мужчин и женщин. По прогнозам абсолютное число случаев колоректального рака в мире в следующие двадцать лет увеличится в результате роста населения в целом и его старения как в развитых, так и в развивающихся странах. Показатели заболеваемости колоректального рака сегодня достигают 85-90 на 100тыс. населения, возрастая с 24,9 – в возрастной группе до 50 лет до 249,7 – среди пациентов старшего возраста [1].

В Казахстане колоректальный рак занимает одну из ведущих позиций.

Заболеваемость колоректальным раком в среднем на 100 тыс. населения в период с января 2011 по декабрь 2015гг. составил 17,02‰. Абсолютное число впервые выявленных случаев в РК составило 14511,0 из них: мужчин 6937, женщин 7574. Удельный вес по стадиям в среднем составил: I-II -53%, III -32%, IV -15%. Радикально пролеченных пациентов за 5 лет составило 51,6%. Годичная летальность 28,15% [2, 3, 4, 5, 6]. Ежегодно темпы прироста больных с КРР неуклонно увеличиваются.

Цель исследования – провести анализ непосредственных результатов радикальных операций выполненных у 50 больных с колоректальным раком в возрасте старше 75 лет за период с января 2011 года по октябрь 2016 года.

Материал и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 пациентов в возрасте от 75 лет до 92 лет, которым в центре абдоминальной онкологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) с января 2011 года

по октябрь 2016 года были проведены радикальные операции по поводу колоректального рака. Среди пациентов было 22 женщины и 28 мужчин, средний возраст составил $\approx 76,92$ года. Учитывая большую распространенность сопутствующих заболеваний у пациентов старческого возраста, стандартное предоперационное обследование дополняли эхокардиографией, суточным мониторингом артериального давления и сердечного ритма, дуплексным сканированием брахиоцефальных сосудов и вен нижних конечностей.

Гистологический диагноз, стадию процесса, показатель патологоанатомической резекции определяли по патологоанатомическому заключению.

Произведены оперативные вмешательства: правосторонняя гемиколэктомия, левосторонняя гемиколэктомия, резекция сигмовидной кишки, обструктивная резекция прямой кишки, передняя резекция прямой кишки, наложение обходного тонко-толстокишечного анастомоза, удаление культи прямой кишки с рецидивной опухолью, экстирпация прямой кишки, закрытие колостомы с наложением толсто-толстокишечного анастомоза «конец в конец», эндоскопическое удаление малигнизированных полипов.

Во время операций было наложено 38 толстокишечных анастомозов. Из них по локализациям: в восходящем отделе ободочной кишки - 14, в нисходящем отделе ободочной кишки - 6, в сигмовидном отделе толстой кишки - 8, на прямой кишке - 9.

Показатель послеоперационной летальности определяли за время госпитализации. Осложнения квалифицировали по шкале Dindo-Clavien, стратифицирующий все виды осложнений от минимальных, не требующих какой-либо коррекции, до тяжелых [7]. Продолжительность пребывания определяли со дня поступления в стационар.

Результаты исследования. У 49 пациентов гистологически была выявлена аденокарцинома, из них у четверых муцинозная аденокарцинома, в том числе в одном случае с нейроэндокринным компонентом. По степени дифференцировки опухоли в 35 случаях выявили умереннодифференцированную степень, в 7 низкодифференцированную, в 3 недифференцированную степень. У одного пациента обнаружен перстневидноклеточный рак. По локализации опухоли были расположены у 3 пациентов – в слепой кишке, у 13 – в ободочной кишке, у 13 – в сигмовидной кишке, у 4 – в ректосигмоидном отделе толстой кишки и у 17 пациентов опухоль

Таблица 1- Средний объем кровопотери по локализациям

Год	Локализация				
	Слепая кишка	Ободочная кишка	Сигмовидная кишка	Ректосигмоидный отдел толстой кишки	Прямая кишка
2011	0	250,0	150,0	0	383,33
2012	0	400,0	100,0	0	300,0
2013	0	300,0	500,0	0	250,0
2014	0	250,0	200,0	225,0	142,0
2015	0	200,0	350,0	0	400,0
2016	262,5	366,67	250,0	0	275,0
Среднее значение:	262,5	294,45	258,33	225,0	291,72

Средняя кровопотеря во время операции по поводу колоректального рака составила $\approx 288,0$ мл. Максимальный объем кровопотери во время операции на ободочной кишке: 600,0 мл. Минимальный объем кровопотери во время операции на прямой кишке: 10,0 мл. Средняя кровопотеря во время операции на слепой кишке составила – 262,5 мл, на ободочной кишке – 294,45 мл, на сигмовидной кишке – 258,33 мл, на ректосигмоидном отделе толстой кишки – 225,0 мл, на прямой кишке – 291,72 мл.

Таблица 2- Средняя длительность послеоперационного периода пациентов в стационаре по локализациям

Год	Локализация				
	Слепая кишка	Ободочная кишка	Сигмовидная кишка	Ректосигмоидный отдел толстой кишки	Прямая кишка
2011	0	31	15,5	0	36
2012	0	12	13	0	14
2013	0	14	12,67	0	12,8
2014	0	15	10	15,5	12,4
2015	0	14	14	0	15
2016	14	11,67	10,5	0	13
Среднее значение:	14	16,28	12,61	15,5	17,2

Среднее количество койко-дней после операции по поводу колоректального рака составило $\approx 15,8$. Максимальное количество – 54 и минимальное – 6 койко-дней составило при операции на прямой кишке.

Средняя длительность послеоперационного периода на слепой кишке составила – 14 койко-дней, на ободочной кишке – 16,28, на сигмовидной кишке – 12,61, на ректосигмоидном отделе толстой кишки – 15,5, на прямой кишке – 17,2 койко-дней.

Таблица 3 – Средняя длительность операций по локализациям

Год	Локализация				
	Слепая кишка	Ободочная кишка	Сигмовидная кишка	Ректосигмоидный отдел толстой кишки	Прямая кишка
2011	0	190	107,5	0	180
2012	0	190	115	0	120
2013	0	123,75	131,67	0	171
2014	0	200	105	112,5	125
2015	0	130	202,5	0	140
2016	156,67	188,33	112,5	0	125
Среднее значение:		129,76	129,03	112,5	143,5

Средняя длительность операций по поводу колоректального рака составила $\approx 159,3$ минуты. Максимальное время, которое было затрачено на операцию – 295 минут (на прямой кишке). Минимальное время, затраченное на операцию – 50 минут (на сигмовидной кишке). Средняя длительность операций на слепой кишке составила – 156,67 мин, на ободочной кишке – 129,76 мин, на сигмовидной кишке – 131,83 мин, на ректосигмоидном отделе толстой кишки – 112,5 мин, на прямой кишке – 143,5 мин.

Таблица 4 Средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре по локализациям

Год	Локализация				
	Слепая кишка	Ободочная кишка	Сигмовидная кишка	Ректосигмоидный отдел толстой кишки	Прямая кишка
2011	0	42	24	0	42,67
2012	0	18,5	14	0	15
2013	0	17,5	19	0	18,6
2014	0	19,5	14	19,5	18
2015	0	19	18	0	18
2016	19,67	16,67	14,5	0	15
Среднее значение:	19,67	22,2	17,25	19,5	21,21

Средняя продолжительность пребывания пациентов в стационаре по поводу лечения колоректального рака составила $\approx 19,97$. Максимальное количество – 56 и минимальное – 8 койко-дней составило при операции на прямой кишке. Средняя продолжительность пребывания в стационаре с с-г слепой кишки составила – 19,67 койко-дней, ободочной кишки – 22,2, сигмовидной кишки – 17,25, ректосигмоидного отдела толстой кишки – 19,5, прямой кишки – 21,21 койко-дней.

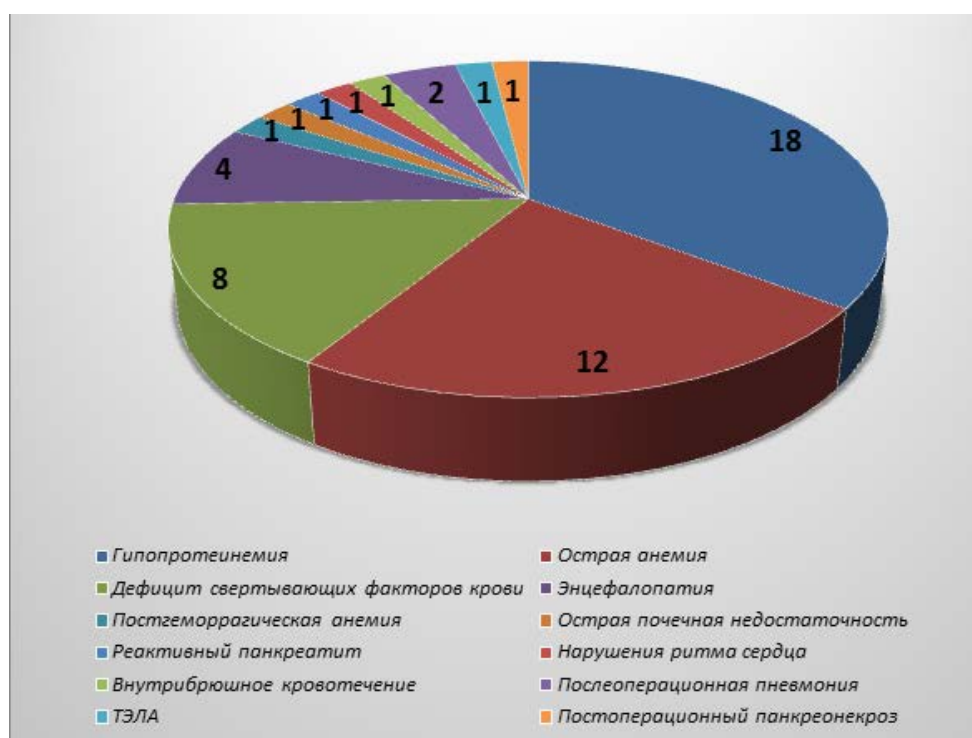


Диаграмма 1 – Послеоперационные осложнения

У 36 из 50 пациентов развились осложнения, в том числе у 14 больных более 1 осложнения. У одной пациентки проводилась релапаротомия по поводу внутрибрюшного кровотечения.

Обсуждение и выводы. По данным мировой литературы, мнение ученых сходит в необходимости применения комплексной оценки состояния каждого больного старческого возраста вне зависимости от локализации опухолевого процесса при колоректальном раке [14, 15-17, 21-24]. По мнению А. Cervantes, объективный осмотр и оценка состояния больного имеет важное значение в успешном лечении рака прямой кишки, так как значительно увеличивает вероятность радикального хирургического вмешательства.[19]. J. Mongan указывает на необходимость участия различных специалистов, в том числе геронтолога или специалиста гериатрической онкологии, без которых адекватно оценить влияние одного из основных факторов риска периоперационных осложнений невозможно. Исследования доказывают, что учет всех сопутствующих заболеваний и степени их компенсации в предоперационном периоде повышает вероятность благоприятного послеоперационного исхода [20].

В работах Т. Latkauskas и соавт. было показано, что у 80% больных колоректальным раком старше 75 лет имелись 2 и более сопутствующих заболеваний. Среди пациентов моложе 75 лет несколько сопутствующих заболеваний наблюдались в 55% случаев [18]. Характер и количество сопутствующих заболеваний связаны с риском развития послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности [9, 11, 12, 13]. Большинство исследователей в наше время утверждают, что лечение и коррекция сопутствующих заболеваний в предоперационный период улучшают течение послеоперационного периода [23-25].

В исследованиях российских ученых указывается на значительное преобладание поздних и запущенных форм заболевания колоректального рака у 77% лиц старше 75 лет и встречается в 2 раза чаще, чем у лиц моложе 75 лет. Это приводит к увеличению числа хирургических вмешательств, из которых радикальность не превышает 15% [8, 10].

Наши полученные результаты соответствуют мировым данным в хирургическом лечении колоректального рака у пациентов старше 75 лет. Как видно из наших вышеизложенных результатов, схожие показатели достижимы при выполнении обширных радикальных вмешательств по поводу КРР. Так же особое внимание уделяется предоперационной подготовке и интраоперационной тактике введения больного, так как риски возникновения послеоперационных осложнений прямо пропорционально увеличиваются с количеством некорректированных сопутствующих заболеваний.

Основанием для проведения радикальных операций с КРР у больных старческого возраста должны проводиться по тем же показаниям, что и у лиц более молодого возраста. При этом больные должны быть достаточно обследованы по поводу сопутствующих заболеваний и проведена их коррекция. Риски проведения оперативных вмешательств в данной возрастной группе сопоставимы с рисками в более молодом возрасте. Данная категория больных должна оперироваться в специализированных онкологических отделениях, в которых возможно оказание высококвалифицированной хирургической и реанимационной помощи. Отказ от наложения толсто-толстокишечных анастомозов у лиц возраста является порочной практикой и должен осуществляться только по строгим показаниям.

Список литературы

1. Torre L.A., Bray F., Siegel R.L. et al. Global cancer statistics, CA // Cancer J. Clin. -2015.-Vol. 65, N 2.- P. 93-95.
2. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011.-Алматы, 2012. – С.78-97.
3. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012год.-Алматы, 2013. – С.75-93.
4. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 год.-Алматы, 2014. – С.90-114.
5. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 год.-Алматы, 2015. – С.99-125.
6. Нургалиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2015год.-Алматы, 2016.
7. Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of survey // Ann. Surg. -2004 Aug. – Vol. 240, N 2. – P.205-213.
8. Атуи А.А. Хирургическая тактика при осложненном колоректальном раке у больных пожилого возраста /автореф.дис. канд.мед. наук.– Ростов-н/Д., 2001.
9. Воробьев В.В. Клиническая оценка сфинктерсохраняющих операций при раке прямой кишки у больных пожилого возраста /автореферат. – Ростов-на-Дону. – 2000.
10. Воробьев Г.И. Непосредственные результаты передней резекции прямой кишки по поводу рака у лиц пожилого и старческого возраста (история вопроса и собственные данные) // Клин. геронтология. – 2002. – Т. 8, № 12.– С. 13–18.
11. Дмитриев М.О. Хирургическое лечение осложненного колоректального рака у лиц пожилого и старческого возраста /автореф. дис.... канд. мед. наук. – Владивосток. – 2007.
12. Сулейман Т.А. Хирургическое лечение рака прямой кишки у больных пожилого и старческого возраста /автореф дис.... канд. мед. наук. – СПб. – 2000.
13. Царюк В.Ф. Возможности хирургического лечения рака прямой кишки у лиц пожилого возраста // Медицинские проблемы пожилых. – 1999.
14. Audisio R.A. et al. Shall we operate? Preoperative assessment in elderly cancer patients (PACE) can help. A SIOG surgical task force prospective study //Crit. Rev. Oncol. Hematol. – 2008. – Vol. 65, N 2. – P.156–163.
15. Golfinopoulos V., Pentheroudakis G., Pavlidis N. Treatment of colorectal cancer in the elderly: a review of the literature // Cancer Treat. Rev. – 2006. – Vol. 32, N 1. – P. 1–8.
16. Gosney M. Letter to the Editor. Age Ageing, 2006.
17. Helwick C. Information for patients. HER2+ early breast cancer: understanding adjuvant treatment // Oncology (Williston Park). – 2009. – Vol. 23 (11 Suppl Nurse Ed.). – P. 8a–8b.
18. Latkauskas T. et al. The impact of age on post-operative outcomes of colorectal cancer patients undergoing surgical treatment // BMC Cancer. – 2005. – Vol. 5. – P. 153.
19. Martin-Martorell P. et al. Biweekly cetuximab and irinotecan in advanced colorectal cancer patients progressing after at least one previous line of chemotherapy: results of a phase II single institution trial // Br. J. Cancer. – 2008. – Vol. 99, N 3. – P. 455–458.
20. Mongan J. et al. Management of colorectal cancer in the elderly // Clin. Geriatrics. – 2010. – Vol. 18 (Issue 1).
21. Papamichael D. et al. Treatment of the elderly colorectal cancer patient: SIOG expert recommendations // Ann. Oncol. – 2009. – Vol. 20, N 1. – P. 5–16.
22. Pope D. et al. Pre-operative assessment of cancer in the elderly (PACE): a comprehensive assessment of underlying characteristics of elderly cancer patients prior to elective surgery // Surg. Oncol. – 2006. – Vol. 15, N 4. – P. 189–197.
23. Ramesh H.S. et al. Optimising surgical management of elderly cancer patients // World J. Surg. Oncol. – 2005. – Vol. 3, N 1. – P. 17.
24. Sanoff H.K., Goldberg R.M. Colorectal cancer treatment in older patients // Gastrointest. Cancer Res. – 2007. – Vol. 1, N 6. – P. 248–253.
25. Sun W. Management and outcome of colorectal cancer in elderly patients // Clin. Colorectal. Cancer. – 2003. – Vol. 3, N 3. – P. 172–173.

ТҰЖЫРЫМ

М.А. Кузикеев, С.В. Лашкул, А.И. Джуманов, Т.С. Насрытдинов, Р.К. Мустафина, О.А. Александрова
Қазақ онкология және радиология ғылыми- зерттеу институты

Кәрі жастағы адамдардағы колоректальды ісікті радикалды хирургиялы емдеу нәтижелері

Бұл жұмыста 2016 жылдың қазаны мен 2011 жылдың қаңтары аралығындағы 75 және 92 жас арасындағы 50 науқасқа колоректальды ісік бойынша жүргізілген хирургиялық емнің нәтижелері беріледі. Бағылау жүргізілді: қан кету көлемі, операция ұзақтығы, операциядан кейінгі асқынулар науқастың стационарда болу ұзақтығы, операциядан кейінгі кезеңнің ұзақтығы. Операция алды дайындыққа еренше назар аударылды, себебі үлкен жастағы науқастарда түзеуді қажет ететін ауыр қосымша ақаулар болады.

Түйінді сөздер: колоректальды ісік, кәрілік жас, тоқ ішек резексиясы.

SUMMARY

M.A. Kuzikeev, S.V. Lashkul, A.I. Dzhumanov, T.S. Nasrytdinov, R.K. Mustafina, O.A. Alexandrova
Kazakh Institute of Oncology and Radiology

Results of radical surgical treatment of a colorectal cancer at persons of senile age

In this work immediate results of surgical treatment of a colorectal cancer (CRC) at 50 patients aged from 75 to 92 years from January, 2011 till October, 2016 are lit. Assessment is made: volume of a hemorrhage, duration of operations, postoperative complications, duration of stay of the patient in a hospital, duration of the postoperative period. Special attention was paid to preoperative preparation as people of a senile age have heavy accompanying pathologies demanding correction.

Keywords: colorectal cancer, senile age, resection of a large colon.